

Консервативное лечение больных раком молочной железы пожилого и старческого возраста

К.И.Ниязбекова

ГККП Алматинский региональный онкологический диспансер

В структуре онкопатологии женского населения Республики Казахстан за последние годы рак молочной железы переместился с пятого на первое место [1].

Риск развития рака молочной железы в возрасте старше 65 лет в 150 раз выше таковой у лиц моложе 30 лет. Женщины с раком молочной железы пожилого и старческого возраста чаще обращаются в специализированные лечебные учреждения с уже распространенным процессом и наличием сопутствующей патологии, которая влияет на течение заболевания, выбор тактики лечения и выживаемость [2].

Несмотря на то, что в последние годы появилось отдельное публикации о возможности консервативного лечения рака молочной железы у женщин пожилого и старческого возраста, в частности с помощью гормональной терапии (ГТ), либо сочетания ГТ с лучевой терапией, которые с успехом могут проводиться даже в амбулаторных условиях, вопросы проведения полихимиотерапии требуют дальнейшего изучения [3,4,5].

Проведен ретроспективный анализ историй болезни и амбулаторных карт больных раком молочной железы пожилого и старческого возраста (60-80 лет и выше), получавших специализированное лечение в условиях Алматинского регионального онкологического диспансера в период с 2004г по 2010г.

Женщины с раком молочной железы пожилого и старческого возраста были в глубокой менопаузе сроком 10-30 лет.

Проводилось комплексное обследование, включающее клинично-инструментальные (рентгенологические, ультразвуковые и др), лабораторные и морфологические исследования, после которых устанавливался не только окончательный диагноз, но и выявлялась сопутствующая патология (у многих больных впервые).

Диагноз был подтвержден не только цитологически и морфологически, но и проводилось иммуногистохимическое исследование с определением рецепторов на онкомаркеры.

На догоспитальном этапе морфологически верифицирован РМЖ у 85 больных, из них женщины с сопутствующей патологией 55 (64%). После верификации процесса определялась дальнейшая тактика лечения с учетом стадии процесса и сопутствующей патологии.

Соответственно классификации TNM (ВОЗ, 1998 год), в группе больных, получивших консервативное лечение, у 40 больных (47%) установлено II стадия опухолевого процесса, у 42 (49,4%) больных –III стадия, и у 3(3,5%) больных IV стадия.

У больных раком молочной железы пожилого и старче-

Консервативное лечение больных раком молочной железы пожилого и старческого возраста

К.И.Ниязбекова

Алматинский региональный онкологический диспансер

В данной статье обобщен опыт по консервативному лечению рака молочной железы у больных пожилого и старческого возраста.

Сүт безінің қатерлі ісігіне шалдыққан егде және қарт жасындағы науқастардың консервативті емі

К.И.Ниязбекова

Алматы аймақтық онкологиялық диспансері

Осы мақалада Алматы аймақтық онкологиялық диспансеріндегі сүт безінің қатерлі ісігіне шалдыққан егде және қарт жасындағы науқастарды консервативті емдеуден кейінгі нәтижелері жинақталып көрсетілген.

Treatment of mummer cancer in elderly and senile age

K.I.Niyazbekova

Almaty Regional Oncological Hospital

Current article generalized experience of Almaty regional oncological hospital on treatment of mummer cancer in elderly and senile age.

ского возраста сопутствующая патология распределилась следующим образом:

Наиболее часто (30,5%) больные имели сердечно-сосудистую патологию (ИБС, стенокардия, артериальная гипертензия, в анамнезе инфаркт миокарда) - 26 женщин.

Сахарный диабет I или II типа отмечен у 17(20%) больных раком молочной железы (у 6 больных впервые выявленный в условиях нашей клиники).

III-группа –12 (14,1%) больных с прочими сопутствующими заболеваниями (бронхиальная астма, хронические заболевания легких, заболевания мочеполовой системы и.т.д.).

Наличие сопутствующей патологии и распространенность опухолевого процесса у 55 больных (64,7%) были одной из основных причин проведения консервативной терапии. В некоторых случаях причиной проведения консервативной терапии был отказ больных от хирургического лечения. Выявление сопутствующей патологии способствовало проведению дополнительных диагностическо-консультативных и лечебных мероприятий, направленных на улучшение статуса больных при проведении запланированного консервативного лечения.

ПХТ проводилось по схемам CMF (циклофосфан 600 мг/м² в 1-й день, метотрексат 40 мг/м² в 1-й и 8 дни, 5-фторурацил 600 мг/м² в 1-й и 8-й дни), CAF (циклофосфан 500 мг/м² в 1-й день, доксорубин 50 мг/м² в 1-й и 8 дни, 5-фторурацил 500 мг/м² в 1-й и 8-й дни), CAMF (циклофосфан 600 мг/м² в 1-день, метотрексат 50 мг/м² в 1-й и 8 дни, 5-фторурацил 600мг/м² в 1-й и 8-день, доксорубин 50 мг/м² в 1-й

Таблица №1. Распределение больных РМЖ пожилого и старческого возраста по сопутствующей патологии

Возраст	I-группа: сердечно-сосудистая патология	II-группа: сахарный диабет	III-группа: прочие заболевания
60-70 лет	18	11	3
70-80 лет	6	5	8
80 и выше	2	1	1
Всего	26	17	12

день) 3-6 курсов.

ГТ включала в себя длительный (более 5 лет) прием больными тамоксифена.

Токсические проявления во время и после проведения ПХТ оценивали соответственно шкале токсичности (NCIC).

При соответствующей коррекции и сопроводительной терапии токсические проявления не требовали прекращения запланированного лечения.

Таким образом, консервативное лечение больных раком молочной железы в пожилом и старческом возрасте является методом выбора при наличии сопутствующей патологии и у больных, отказавшихся от хирургического лечения.

Список использованной литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Ж. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2009 году (статистические материалы), Алматы, 2010.
2. Абдрахманова А.Ж. К эпидемиологии рака молочной железы в Казахстане. Актуальные вопросы современной онкологии. Сборник научных трудов. Бишкек, 1998 год.
3. Абисатов Х.А. Клиническая онкология, том 2 «Арыс», Алматы, 2007.
4. Иванов В.М., Летягин В.П., Высотская И.В. Лечение рака молочной железы у больных пожилого и старческого возраста. М., 2001.
5. Особенности лечения рака у пожилых людей // Материалы Российского национального конгресса «Человек и лекарство» под редакцией В.А.Горбунова.-М., 1999.